Клинические рекомендации

Травма носа

Конспект для врача-оториноларинголога

Коды МКБ-10	**S00.3** — Поверхностная травма носа **S01.2** — Открытая рана носа **S02.2** — Перелом костей носа
Пациенты	взрослые, дети
Рекомендация	опубликована в рубрикаторе Минздрава 20.11.2024, пересмотр не позднее 2027 года
Разработчик	Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов
Полный текст	cr.minzdrav.gov.ru/view-cr/815_1

Конспект клинических рекомендаций Минздрава РФ. Каждый пункт сверен с текстом КР 22.10.2026; неточности самой рекомендации собраны в последнем разделе «Источник и актуальность». Конспект не заменяет полный текст.

Оглавление

1. Основные положения 3

2. Клиническая картина и классификация 3

2.1 Определения 3

2.2 Механизм травмы 4

2.3 Классификация 4

2.4 Клиническая картина 4

2.5 Жалобы и анамнез 5

3. Диагностика 5

3.1 Физикальное обследование 5

3.2 Лабораторные исследования 5

3.3 Инструментальные исследования 6

3.4 Консультации специалистов 6

4. Лечение 6

4.1 Обезболивание 6

4.2 Анальгетики у взрослых 7

4.3 Анальгетики у детей 7

4.4 Профилактика столбняка и антибактериальная терапия 8

4.5 Противоотёчная, гемостатическая и местная терапия 9

4.6 Хирургическое лечение 10

4.7 Анестезия, тампонада и фиксирующая повязка 11

5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации 11

5.1 Показания к госпитализации 12

6. Источник и актуальность 12

6.1 Неточности и противоречия в тексте рекомендации 12

1. Основные положения

- Для выявления перелома костей носа взрослым и детям с 3 лет выполняют рентгенографию костей лицевого скелета в боковой проекции; чувствительность метода не превышает 70%, поэтому отсутствие изменений на рентгенограмме не исключает перелома.
- При гематоме или абсцессе перегородки носа показаны вскрытие и дренирование с последующей передней тампонадой и ежедневными перевязками до прекращения отделяемого.
- При травматической деформации носа показаны репозиция костей и фиксация отломков. Раннюю операцию выполняют в первые 7 суток; при тяжёлом состоянии или выраженном отёке вмешательство может быть отложено до 15 суток.
- При изолированном переломе, в том числе открытом, рутинное назначение системных антибиотиков не показано. Антибактериальную терапию применяют при загрязнённых и гнойных ранах, выраженном отёчно-токсическом синдроме, осложнённой гематоме или абсцессе перегородки носа, сочетанной и комбинированной травме и тяжёлой сопутствующей патологии.
- При повреждении кожи или слизистой оболочки и загрязнении раны землёй необходима экстренная профилактика столбняка в максимально ранние сроки, но не позднее 20-го дня после травмы.
- Показаниями к госпитализации являются тяжёлое состояние, кровотечение, выраженный отёк или болевой синдром, деформация носа со смещением перегородки, осложнения травмы, тяжёлая сопутствующая патология, приём антикоагулянтов или антиагрегантов, а также необходимость закрытой репозиции.

2. Клиническая картина и классификация

2.1 Определения

Травма носа представляет собой повреждение носа в результате прямого или опосредованного воздействия травмирующего фактора снаружи или изнутри, сопровождающееся нарушением целостности тканей и структур наружного носа и полости носа и нарушением функций носа.

Поверхностной называется травма наружного носа без повреждения кожи, костей носа и слизистой оболочки полости носа и без неврологической симптоматики.

Ушиб носа является закрытым повреждением тупым предметом без видимого нарушения целостности кожи и слизистых оболочек, с разрывом мелких сосудов и кровоизлиянием. При кровоподтёке кровь пропитывает мягкие ткани наружного носа, тогда как гематома представляет собой скопление крови в ограниченной полости. Ссадиной называется повреждение поверхностного слоя кожи с визуально определяемым местом размозжения кожных сосудов.

Перелом костей носа (ПКН) характеризуется частичным или полным нарушением целостности носовых костей, лобных отростков верхней челюсти, перегородки носа или носовой ости. Перелом считается закрытым при сохранённой целостности кожи носа и открытым, если отломки сообщаются с внешней средой через рану.

Раной носа называется повреждение кожи наружного носа на всю глубину, часто с обнажением хрящей и костей и более глубоких структур полости носа, в ряде случаев с отрывом крыла или кончика носа.

2.2 Механизм травмы

При ударе во фронтальной плоскости возникает перелом носовых костей с западением спинки носа. Боковой удар может приводить к разъединению носовой кости и лобного отростка верхней челюсти с формированием сколиоза наружного носа, однако чаще линия перелома проходит выше шва между ними. Как правило, одновременно возникает перелом перегородки носа, чаще её хрящевого отдела.

У детей младшего возраста кости наружного носа эластичны, поэтому переломы встречаются редко, а гематома и абсцесс перегородки носа чаще.

При переломе нередко происходит разрыв и отслойка надхрящницы или надкостницы перегородки, кровь скапливается между хрящом и надхрящницей, и формируется гематома перегородки носа. При её инфицировании развивается абсцесс, четырёхугольный хрящ расплавляется, что приводит к деформации носа и нарушению его функций.

Травма носа может быть изолированной или сочетаться с повреждением околоносовых пазух, глаза, скуловой области, нижней челюсти, полости рта, ушной раковины, сотрясением или ушибом головного мозга.

2.3 Классификация

Общепринятая классификация переломов отсутствует. Согласно классификации Ю. Н. Волкова (1958), выделяют открытые и закрытые переломы, переломы без деформации и с деформацией наружного носа.

Согласно классификации С. Б. Бесшапочного (1984), переломы подразделяются на переломы без деформации и с деформацией наружного носа; последние могут быть одно- и двусторонними, с боковым смещением отломков, со смещением кзади или с сочетанием обоих видов смещения.

Согласно классификации А. С. Лопатина (2019), выделяют изолированные и сочетанные, открытые и закрытые переломы; переломы со смещением подразделяются по направлению удара на латеральные, фронтальные, фронтолатеральные и базальные.

По распространённости выделяют изолированные переломы (с деформацией наружного носа или без неё), комбинированные (с травмой кожи лица, внутриносовых структур или околоносовых пазух) и сочетанные (с челюстно-лицевой или черепно-мозговой травмой, травмой конечностей, туловища и внутренних органов).

В течении перелома со смещением выделяют три стадии. Острая стадия охватывает первые 14 дней; в этот период кости репонируют по стандартной методике. Застарелый перелом соответствует сроку от двух недель до двух месяцев; репозиция возможна только в сочетании с операцией на перегородке носа. Стойкая деформация констатируется при давности травмы более двух месяцев; сопоставление отломков возможно только после остеотомии.

2.4 Клиническая картина

Поверхностная травма характеризуется слабо выраженными проявлениями: в месте удара отмечаются боль, небольшая припухлость и умеренная гиперемия кожи без нарушения её целостности.

При ушибе пирамида носа увеличена в объёме, контуры её сглажены за счёт отёка; при кровоподтёке и ссадине изменены цвет и целостность кожи; при переломе пирамида носа смещена в сторону или вдавлена; при гематоме перегородка носа утолщена, носовые ходы сужены. Возможны носовое кровотечение, боль и болезненность при пальпации, нарушение дыхания и обоняния. При сочетанной травме отмечаются также отёки, кровоподтёки, гематомы и раны других областей, нарушения зрения и сознания.

Перелом характеризуется отёком, болью, деформацией наружного носа, крепитацией и подвижностью отломков, носовым кровотечением и затруднением носового дыхания.

У детей с переломом деформация носа вследствие выраженного отёка определяется лишь в 57,5% случаев. Кроме того, у 7,4% детей деформация имелась до травмы.

При переломе нередко повреждены кожа носа и слизистая оболочка полости носа, возможны эмфизема мягких тканей носа и лица, экхимозы. Носовое кровотечение встречается часто, однако при неосложнённом изолированном переломе обильное и рецидивирующее кровотечение отмечается редко.

Перелом часто сопровождается кровоизлиянием в веки и мягкие ткани орбиты («симптом очков»), однако этот же симптом наблюдается при переломе переднего основания черепа и травме кавернозного синуса.

Крепитация и подвижность отломков выявляются менее чем в половине случаев, поэтому их отсутствие не исключает перелома. Болевой синдром в области носа также неспецифичен и встречается при ушибах и воспалительных заболеваниях носа.

2.5 Жалобы и анамнез

Необходимо выяснить обстоятельства и механизм травмы, направление удара, наличие потери сознания. Уточняются перенесённые ранее травмы носа с деформацией и операции на носу. При комбинированной травме с повреждением кожи следует уточнить прививочный анамнез в отношении столбняка. При общем осмотре оцениваются артериальное давление, пульс и частота дыхания.

---

3. Диагностика

Диагноз устанавливается на основании факта травмы со слов пострадавшего или очевидцев; жалоб на боль, изменение формы носа, затруднение дыхания, кровотечение и нарушение обоняния; данных осмотра: повреждения кожи, деформация, крепитация и подвижность отломков, кровотечение. Перелом подтверждается рентгенографией костей лицевого скелета, при противопоказаниях ультразвуковым исследованием (УЗИ) костей носа. При сочетанной травме для выявления повреждений околоносовых пазух, орбиты, скуловой кости, верхней челюсти и черепа необходимы рентгенография черепа и компьютерная томография (КТ).

3.1 Физикальное обследование

Каждого пациента с травмой носа осматривает оториноларинголог для определения характера и выраженности повреждений.

Всем пациентам показана пальпация челюстно-лицевой области для уточнения характера травмы и выраженности повреждений.

При осмотре фиксируются отёк, гематомы, ссадины и раны, наличие и выраженность деформации. При пальпации выявляются крепитация отломков, подкожная эмфизема и гематома, оцениваются область носового клапана, подвижность крыльев носа и подвижной части перегородки. Для врачебной и судебно-медицинской экспертизы важна фотофиксация повреждений.

3.2 Лабораторные исследования

При травме, сопровождающейся кровотечением, исследуют коагулограмму для оценки системы гемостаза и кровопотери и подготовки к возможному хирургическому вмешательству.

3.3 Инструментальные исследования

Взрослым и детям с 3 лет для выявления костных повреждений выполняется рентгенография костей лицевого скелета.

Рентгенограмма в боковой проекции имеет как диагностическое, так и юридическое значение: в 70,2% случаев она позволяет выявить перелом и характер смещения отломков. Как правило, повреждаются обе носовые кости, однако встречаются одиночные и множественные переломы, поэтому для уточнения стороны перелома боковые снимки выполняют в положении головы на левой и на правой стороне.

Чувствительность рентгенографии при переломе костей носа не превышает 70%, смещение во фронтальной плоскости на боковом снимке не визуализируется. У детей до 3 лет исследование малоинформативно вследствие слабой оссификации и преобладания хрящевой ткани. Поэтому отрицательный результат не исключает перелома.

При подозрении на смещение отломков в переднезаднем направлении и отсутствии изменений на боковом снимке взрослым и детям с 3 лет показана рентгенография околоносовых пазух.

Смещение отломков снаружи внутрь, не определяемое на боковых снимках, выявляется на рентгенограмме околоносовых пазух в носоподбородочной проекции.

При комбинированной и сочетанной травме черепа показана КТ лицевого отдела черепа или челюстно-лицевой области и (или) КТ головного мозга.

Показаниями к КТ являются комбинированные и сочетанные переломы, признаки черепно-мозговой травмы (ЧМТ), неинформативность рентгенографии при клинических признаках перелома, планирование расширенного вмешательства, подозрение на назальную ликворею, тяжёлое состояние, продолжающееся или рецидивирующее носовое кровотечение. Область исследования определяется сопутствующей патологией.

Чувствительность КТ при переломе приближается к 100%. Исследование выполняют в режиме спирального сканирования с толщиной среза 3 мм; оно позволяет оценить положение отломков, состояние перегородки носа, повреждения околоносовых пазух, орбиты, мозгового черепа, мягких тканей и головного мозга. Перед операцией рекомендуется 3D-реконструкция.

При противопоказаниях к лучевым методам выполняется УЗИ костей носа.

УЗИ является простым неинвазивным методом, не сопряжено с лучевой нагрузкой и может выполняться повторно для контроля репозиции и сращения отломков. Исследование выполняют в четырёх проекциях: передней продольной, передней поперечной, правой и левой боковой.

3.4 Консультации специалистов

При подозрении на повреждение органа зрения необходима консультация офтальмолога.

Всем пациентам с травмой носа рекомендуется консультация невролога для своевременного выявления сопутствующей патологии.

При массивном кровотечении и сочетанной травме регистрируют электрокардиограмму (ЭКГ) для оценки состояния сердечно-сосудистой системы и планирования лечения.

---

4. Лечение

Консервативное лечение направлено на уменьшение болевого синдрома и отёка, профилактику бактериального воспаления в зоне повреждения, ускорение заживления и восстановление функций носа.

4.1 Обезболивание

Всем пациентам при отсутствии противопоказаний назначаются анальгетики.

Выраженный болевой синдром и травматический стресс способствуют развитию или утяжелению травматического шока.

Применяются анальгетики-антипиретики и нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП) по отдельности или в сочетании; у взрослых и детей, в том числе в послеоперационном периоде, рекомендуется сочетание НПВП с парацетамолом, а также метамизол натрия. Из НПВП у детей допустимо применение ибупрофена с 3 месяцев и кетопрофена с 15 лет, кетопрофена в гранулах для приготовления раствора с 6 лет. Метамизол натрия детям амбулаторно не назначают, в стационаре применяют только при отсутствии других разрешённых детям анальгетиков в связи с риском серьёзных нежелательных явлений.

4.2 Анальгетики у взрослых

Препарат	Разовая доза	Интервал	Максимум в сутки	Длительность
Парацетамол	1 г внутривенно, инфузия 15 минут	4 ч	4 г	5–7 суток
Диклофенак	75 мг внутримышечно (в таблице рекомендации указано «75 мл»)	12 ч	150 мг	2 суток
Кеторолак	30 мг внутривенно, внутримышечно	6 ч	60–90 мг	2 суток
Кетопрофен	100 мг внутривенно, внутримышечно	12 ч	200 мг	не более 2 суток
Лорноксикам	8 мг внутривенно, внутримышечно	12 ч	16 мг	1–7 суток
Декскетопрофен	50 мг внутривенно, внутримышечно	8–12 ч	150 мг	2 суток
Метамизол натрия	500–1000 мг внутривенно, внутримышечно	8–12 ч	2 г	1–5 суток

> В таблице 2 разовая доза диклофенака указана как «75 мл в/м», то есть единица измерения приведена неверно; с учётом структуры таблицы и максимальной суточной дозы 150 мг речь идёт о 75 мг.

4.3 Анальгетики у детей

Препарат	Разовая доза	Интервал	Максимум в сутки	Длительность
Парацетамол внутривенно	Инфузия 15 минут: масса тела менее 10 кг — 7,5 мг/кг; 10–50 кг — 15 мг/кг; более 50 кг — 1000 мг	4 ч	Менее 10 кг — до 30 мг/кг; 10–50 кг — до 60 мг/кг, но не более 2 г (для 33–50 кг в той же ячейке указано не более 3 г); более 50 кг — 4 г	5–7 суток
Парацетамол внутрь	10–15 мг/кг	6 ч	не более 60 мг/кг	3–5 суток
Парацетамол ректально	3–12 месяцев — 50–100 мг; 1–3 года — 100–150 мг; 3–5 лет — 150–200 мг; 5–10 лет — 250–350 мг; 10–14 лет — 350–500 мг	6 ч	до 60 мг/кг	до 5 суток

Препарат	Разовая доза	Интервал	Максимум в сутки	Длительность
Ибупрофен внутрь	3–6 месяцев — 50 мг; 6–12 месяцев — 50 мг; 1–3 года — 100 мг; 4–6 лет — 150 мг; старше 6 лет — 200–400 мг	6–8 ч (в ячейке указано также «8 ч» без пояснения)	3–6 месяцев — 150 мг; 6–12 месяцев — 200 мг; 1–3 года — 300 мг; 4–6 лет — 450 мг; 6–12 лет — 800 мг; 12–17 лет — 1 г	4 суток
Ибупрофен ректально	3–9 месяцев — 60 мг; 9–24 месяца — 60 мг	3–9 месяцев — 8 ч; 9–24 месяца — 6 ч	3–9 месяцев — 180 мг; 9–24 месяца — 240 мг	не более 3 суток
Метамизол натрия	С 15 лет — 500–1000 мг внутривенно, внутримышечно; 2–14 лет — 50–100 мг/кг внутримышечно, внутривенно; от 3 месяцев до года — 50–100 мг на 10 кг внутримышечно	8–12 ч	с 15 лет — 2 г	1–5 суток; детям младше 15 лет — 3 суток

> В таблице 3 имеются несогласованности. Для внутривенного парацетамола весовые диапазоны пересекаются: для массы тела 33–50 кг указана максимальная суточная доза 3 г, для 10–50 кг 2 г. Для метамизола натрия детям 2–14 лет указана доза 50–100 мг/кг, детям до года 50–100 мг на 10 кг, то есть в 10 раз меньше в пересчёте на килограмм массы тела. Дозы следует сверить с инструкцией по медицинскому применению.

4.4 Профилактика столбняка и антибактериальная терапия

При повреждении кожи или слизистой оболочки, если травма получена при ударе о землю или в рану попала почва, показано введение вакцины для профилактики столбняка.

Экстренную профилактику выполняют в максимально ранние сроки, вплоть до 20-го дня после травмы, с учётом инкубационного периода столбняка. Она включает первичную хирургическую обработку раны и одновременное введение столбнячного анатоксина, противостолбнячного иммуноглобулина человека или столбнячного антитоксина в соответствии с инструкцией.

При изолированном переломе костей носа, в том числе открытом, рутинное назначение системных антибиотиков до и после операции не рекомендуется.

Профилактическое применение антибиотиков не снижает риск инфекционных осложнений после репозиции костей носа ни у взрослых, ни у детей.

Системные антибиотики назначаются при загрязнённых и гнойных ранах кожи и слизистой оболочки, выраженном отёчно-токсическом синдроме, осложнённой гематоме или абсцессе перегородки носа, сочетанной и комбинированной травме и тяжёлой сопутствующей патологии.

При явном бактериальном воспалении или высоком риске его развития применяют препараты широкого спектра действия из группы бета-лактамов: цефазолин, цефтриаксон, ампициллин с сульбактамом, амоксициллин с клавулановой кислотой. При аллергии на бета-лактамы применяется клиндамицин.
Ампициллин с сульбактамом и амоксициллин с клавулановой кислотой обладают более широкой, чем цефазолин, активностью в отношении грамотрицательных и анаэробных бактерий.

Препарат	Доза
Ампициллин и сульбактам	Внутримышечно и внутривенно. Взрослым в зависимости от тяжести инфекции 3–12 г в сутки в 3 введения, детям — 150 мг/кг в сутки в 3 введения (новорождённым — в 2), в течение 5–14 дней.

Препарат	Доза
Амоксициллин и клавулановая кислота	Внутривенно. Взрослым и детям старше 12 лет — по 1 г (по амоксициллину) 3 раза в сутки, детям младше 12 лет — 25 мг/кг 3 раза в сутки, в течение 5–14 дней.

4.5 Противоотёчная, гемостатическая и местная терапия

При выраженном отёке взрослым и детям старше 15 лет назначаются ангиопротекторы, что позволяет выполнить репозицию отломков в более ранние сроки и предупредить осложнения.

Троксерутин (взрослым и детям старше 15 лет) или гель гепарина натрия наносится местно на спинку носа на неповреждённую кожу 2 раза в день до регресса отёка.

При обильном кровотечении, а также для профилактики интра- и послеоперационного кровотечения назначаются гемостатические средства.

Кровотечение возможно из полости носа и из повреждённых мягких тканей при открытых ранах. Механическая остановка кровотечения, как правило, дополняется назначением гемостатиков: этамзилата, транексамовой или аминокапроновой кислоты.

Препарат	Взрослые	Дети
Этамзилат	Для остановки кровотечения — 250–500 мг внутривенно или внутримышечно, затем по 250 мг каждые 4–6 часов. При репозиции — 250–500 мг за час до операции, при необходимости 250–500 мг во время операции и 500–750 мг равномерно в течение суток после неё.	10–15 мг/кг в сутки в 3–4 приёма, 5–10 дней. Во время операции — 8–10 мг/кг внутривенно, затем 10–15 мг/кг в течение суток.
Транексамовая кислота	Внутривенно капельно или медленно струйно со скоростью 1 мл/мин (50 мг/мин), 10–15 мг/кг каждые 6–8 часов до остановки кровотечения.	Старше 1 года — 20 мг/кг в сутки до остановки кровотечения.
Аминокапроновая кислота	Внутривенно капельно: 4–5 г за первый час, при продолжающемся кровотечении — по 1 г в час не более 8 часов; при необходимости инфузии повторяются каждые 4 часа; не более 30 г в сутки. Курс 3–14 дней.	100 мг/кг за первый час, затем 33 мг/кг в час; не более 18 г/м² в сутки (до года — 3 г, 2–6 лет — 3–6 г, 7–10 лет — 6–9 г, старше 10 лет — как взрослым). При острой кровопотере: до года — 6 г, 2–4 года — 6–9 г, 5–8 лет — 9–12 г, 9–10 лет — 18 г.

> Для аминокапроновой кислоты у детей дозы при острой кровопотере превышают указанные рядом максимальные суточные дозы: например, до года 6 г при максимуме 3 г, в 9–10 лет 18 г при максимуме 6–9 г.

Всем пациентам для облегчения носового дыхания назначаются деконгестанты и другие назальные препараты.

Сосудосуживающие спреи и капли уменьшают реактивный отёк слизистой оболочки после травмы и облегчают носовое дыхание после операции.

Препарат	Доза
Фенилэфрин 0,125%	Интраназально: до года — 1 капля, 1–6 лет — 1–2 капли, старше 6 лет — 3–4 капли до 3 раз в сутки, до 7 дней.
Оксиметазолин	До года — 0,01%, 1–6 лет — 0,025%, старше 6 лет — 0,05%; по 1–2 капли интраназально 2–3 раза в сутки, до 5 дней.
Ксилометазолин	2–6 лет — 0,05%, старше 6 лет — 0,1%; спрей по 1 дозе 2–3 раза в сутки, до 5 дней.

При повреждении кожи или слизистой оболочки с признаками инфицирования раны или высоким риском инфицирования назначаются местные антисептики.

Применяются бензилдиметил-миристоиламино-пропиламмоний (в форме спрея не применяется у детей до 3 лет), повидон-йод и хлоргексидин. Кратность обработки раны определяется выраженностью воспаления и количеством экссудата; обработку продолжают до разрешения инфекции или начала заживления.

Всем пациентам показано промывание полости носа для ускорения заживления слизистой оболочки.

Уход за полостью носа после травмы и операции ускоряет заживление и предупреждает осложнения, например синехии. Применяются стерильные изотонические растворы морской воды 2–3 раза в день до эпителизации слизистой оболочки и стихания воспаления.

4.6 Хирургическое лечение

Неотложные мероприятия при травме носа включают остановку кровотечения и первичную хирургическую обработку открытых ран. При переломе хирургическое лечение направлено на восстановление формы наружного носа, устранение смещения внутриносовых структур и восстановление дыхания.

При открытых ранах и открытых переломах выполняется хирургическая обработка раны с иссечением инфицированных тканей и наложением косметического шва.

Перед наложением шва необходимы тщательная ревизия раны, удаление инородных тел и зондирование раневого канала.

При неэффективности гемостатической терапии и тампонады показана хирургическая остановка кровотечения.

Метод определяется источником кровотечения. При кровотечении из передних отделов применяют отслойку участка мукоперихондрия с последующей тампонадой, выскабливание расширенного сосуда, криокоагуляцию или электрокаустику. При обильном кровотечении показаны перевязка наружной сонной артерии, эндоскопическое клипирование сосудов или эндоваскулярная эмболизация. При кровотечении из решётчатых артерий прибегают к этмоидотомии наружным, внутренним или эндоназальным доступом.

При гематоме или абсцессе перегородки носа показаны вскрытие и дренирование.

После вскрытия выполняют переднюю тампонаду, перевязки проводят ежедневно до прекращения отделяемого.

При травматической деформации наружного носа показаны репозиция костей и фиксация отломков для восстановления формы носа и носового дыхания.

Различают раннюю операцию (в первые 7 суток после травмы), отложенную (на 8–15-е сутки) и плановую (через 6 месяцев и позднее).

Ранняя операция показана при минимальном или умеренном отёке, а также при комбинированной травме с повреждением внутриносовых структур или околоносовых пазух и при гематоме перегородки носа. Раннее вмешательство позволяет избежать септических осложнений и синехий.

При тяжёлом состоянии, выраженном отёке, комбинированных переломах костей и перегородки носа и ранениях лица операция может быть отложена до 15 суток.

> Согласно классификации в разделе 1.5, острая стадия, в которой репозиция костей выполняется по стандартной методике, продолжается 14 дней, а по истечении двух недель репозиция возможна только в сочетании с операцией на перегородке носа. В разделе 3.2 отложенная операция допускается до 15-х суток.

Плановое хирургическое лечение переломов (риносептопластика) показано при сочетанной травме с переломом основания черепа и назальной ликвореей, а также при тяжёлых функциональных нарушениях.

Кости репонируют наружным (пальцевым), эндоназальным (инструментальным) или экстраназальным (открытым) способом. У детей наружный способ эффективен лишь в 22% случаев, поэтому предпочтительна эндоназальная репозиция элеваторами Манакова или Волкова с последующей передней тампонадой. Открытый способ применяется при одновременном хирургическом вмешательстве по поводу внутричерепной травмы или травмы лобных пазух и верхней челюсти.

При комбинированных назосептальных переломах в остром периоде репозицию костей сочетают с септопластикой. При сочетанной травме репозицию предпочтительно проводить совместно с хирургами других специальностей, если вмешательство выполняется под наркозом.

При подозрении на черепно-мозговую травму репозиция откладывается до осмотра невролога или нейрохирурга и проведения необходимых исследований.

4.7 Анестезия, тампонада и фиксирующая повязка

При операциях по поводу открытых и закрытых переломов и смещения внутриносовых структур проводится анестезия наружного носа и полости носа.

Взрослым при изолированной травме применяют аппликационную анестезию слизистой оболочки полости носа в сочетании с внутримышечным введением анальгетиков или проводниковую анестезию артикаином. Детям рекомендуется сочетанная анестезия.

При переломах костей наружного носа и внутриносовых структур выполняется передняя тампонада для удержания сопоставленных отломков и остановки кровотечения при травме слизистой оболочки.

Тампон вводится на стороне деформации и удаляется на 2–3-и сутки после операции; срок определяется подвижностью отломков. Преимущества длительной тампонады (более 3–5 дней) после репозиции не доказаны.

При переломах, сложных травмах и после операций накладывается пращевидная повязка для профилактики смещения отломков.

Наружная шина после закрытой репозиции рутинно не применяется и показана только при тяжёлых оскольчатых переломах.

При выраженных реактивных воспалительных явлениях показана консультация физиотерапевта.

Лазерная физиотерапия челюстно-лицевой области и магнитотерапия уменьшают воспаление и отёк и ускоряют заживление.

На период лечения пациенту рекомендуются ограничение физической активности, исключение действий, способных привести к смещению отломков, в том числе во сне, полноценное витаминизированное легкоусвояемое питание; приём горячей ванны, душа, посещение сауны и бассейна не рекомендуются.

5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации

После операций по поводу деформации наружного носа или перегородки носа пациент в течение года находится под наблюдением оториноларинголога; обязательные осмотры назначают через 1, 3 и 6 месяцев и через год после операции.

Профилактика травм основана на общих социальных мерах предупреждения травматизма.

К ним относятся соблюдение техники безопасности в детских учреждениях, на производстве и в быту, разъяснительная работа с родителями и пропаганда здорового образа жизни.

5.1 Показания к госпитализации

Показаниями к госпитализации являются тяжёлое состояние, выраженный отёк, кровотечение, выраженный болевой синдром; комбинированные переломы костей и перегородки носа с повреждением околоносовых пазух и ранениями лица; травматическая деформация носа со смещением перегородки или нарушением дыхания; тяжёлая сопутствующая патология; приём антикоагулянтов или антиагрегантов; осложнения (гематома и абсцесс перегородки носа, воспаление околоносовых пазух и соседних областей); необходимость закрытой репозиции.

Пациент выписывается при удовлетворительном состоянии и нормальных клинических показателях, улучшении формы носа и носового дыхания и отсутствии осложнений.

Прогноз благоприятный при проведении лечения в соответствии с рекомендациями и выполнении пациентом назначений врача.

Пациенту разъясняется, что при выраженном отёке лица, деформации носа, повреждении мягких тканей, носовом кровотечении или нарушении дыхания необходима экстренная консультация оториноларинголога, поскольку запоздалое лечение может привести к опасным осложнениям.

---

6. Источник и актуальность

Документ	Клинические рекомендации «Травма носа»
Версия	1-я, опубликована в рубрикаторе 20.11.2024
Статус	**Применяется** (каталог рубрикатора на 22.10.2026)
Актуализация	По общему правилу КР пересматривают не реже раза в три года, следующая версия ожидается не позднее ноября 2027 года
Код в рубрикаторе	`815_1` · открыть текст КР ↗
Разработчик	Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов
Пациенты	Взрослые и дети

6.1 Неточности и противоречия в тексте рекомендации

- В разделе 1.4 коды МКБ записаны с лишней точкой («S.00.3», «S.02.2», «S.02.20», «S.02.21»); на титульном листе коды указаны правильно (S00.3, S02.2 и т. д.).
- В таблице 2 разовая доза диклофенака указана как «75 мл в/м» вместо миллиграммов.
- В таблице 3 для внутривенного парацетамола пересекаются весовые диапазоны с разными максимальными суточными дозами (33–50 кг: 3 г; 10–50 кг: 2 г); для метамизола натрия доза у детей 2–14 лет (50–100 мг/кг) в 10 раз больше в пересчёте на килограмм, чем у детей до года (50–100 мг на 10 кг). Для ибупрофена внутрь в графе интервала указаны одновременно «6–8 ч» и «8 ч» без пояснения.
- Для аминокапроновой кислоты у детей дозы при острой кровопотере (до года 6 г, в 9–10 лет 18 г) превышают указанные рядом максимальные суточные дозы (3 г и 6–9 г).
- Острая стадия перелома в разделе 1.5 составляет 14 дней, тогда как в разделе 3.2 отложенная операция допускается до 15-х суток.
- Критерии качества требуют выполнения рентгенографии или КТ у всех пациентов, тогда как рентгенография рекомендована только с 3 лет.
- В рекомендации о коагулограмме указано «система гомеостаза» вместо «гемостаза»; в оглавлении номера страниц разделов 6, 7 и критериев качества не совпадают с текстом.